李議員偉智：

我跟你說，騎車過去可能油錢就 50 元了，而且手搖飲料現在可能要 60 元，就 200 元發一發嘛！肝炎現在好不容易控制好，一直往下降，當然我們局也很努力，但 7 成還有 3 成的空間，把它篩一篩，你也知道，提早篩一篩，未來醫療健保的支出就會少很多，是不是這樣子?

衛生局李局長翠鳳：

是，我們努力。

李議員偉智：

另外 8 成的國民健康檢查，檢查完之後沒有全部符合標準的可能是有幾項超標，一般可能是血脂或血壓，大部分是這樣，而且這個有年輕化的跡象。我們在選區跑，很多年輕人心肌梗塞，這 40 歲、50 歲都常見到，所以這個部分我個人覺得你的 8 成可能是 65 歲以上，但 40 歲以上到 65 歲的青壯年比例可能還沒有很高，不要以為慢性病年輕人不會有，除了 B 型肝炎跟 C 型肝炎之外，我希望局長要重視 41 歲到 65 歲的青壯年，他高血脂、高血壓的部分可能都有了，只是沒有症狀，他就不會去注意，也不會覺得要健檢，宣導也不夠好，請假又要扣錢，當然健康是自己的，但你站在一個衛生主管機關的角度來講，你還是要去關心一下你的市民，好不好？

衛生局李局長翠鳳：

好。

李議員偉智：

我覺得可以去研議一下，因為現在已經到 8 成了，剩下 2 成其實不多，去跟市長提個預算看看，給他車馬費 200、300 元來檢查完，那我們自己手上的數據就可以告訴我們可能只有 1/3 有高血脂高血壓，可能啦!因為我看很多縣市差不多就是 1/3、1/4 左右，不高，這樣你就可以跟市長說我們的市民是很健康的，路跑、爬山樣樣行，不用擔心會有一些緊急的狀況，局長這個會後研議一下，我覺得這是個很好的事情。

衛生局李局長翠鳳：

是，跟議座報告，現在是這樣，會訂出每一個族群的年齡是因為要研究背景高風險，我們努力先做完這一塊再來擴大。

李議員偉智：

對，我只是提醒你一些慢性病現在有年輕化的跡象，高血壓高血脂的問題可能在 40 歲左右就開始發生了。

衛生局李局長翠鳳：

好，目標族群之外怎麼努力推動我們再來研議。

李議員偉智：

另外，你今天簡報提的第 21 頁「HPV 疫苗接種對象」，上次會期本席已經質詢過你，你的效率也不錯，我個人覺得讚賞，現在本府已經編列 114 年的疫苗分攤款項 397 萬，全臺南市你一年大概要編多少預算可以幫國中生的男生做 HPV 疫苗的注射？

衛生局李局長翠鳳：

因為中央疫苗占 7 成，我們自己要負擔 3 成，是 300 多萬，這 300 多萬就是全部的國中男生。

李議員偉智：

一次就可以到位了？

衛生局李局長翠鳳：

對。

李議員偉智：

中央也答應補助了嗎？

衛生局李局長翠鳳：

對，市長也很支持很同意。

李議員偉智：

那 114 年就會全面去進行了嗎？

衛生局李局長翠鳳：

對，會，包括男生女生都會打。

李議員偉智：

好，謝謝。

主席：（陳議員皇宇）

我們請穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。社會局，我們上個會期有提到職務再設計這件事情，真心希望今天因為身體或是心理有一些病徵的狀況之下，不要被中華民國的政治體制給排擠到社會的邊緣再邊緣，他們其實並不是失能，只是他可能沒有像一般勞工這樣產出的能力，所以應該要做調整，而不是眼睛不方便的就只能做按摩師，眼睛不方便的就只能去做接線生等等之類的，感覺他好像不在這個社會上被視為一個勞動力。

社會局盧局長禹璁：

對，而且被標籤化了。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

對，之前提過，社會局感覺起來只能把他丟到小作所裡面去，等到他 65 歲之後再丟到安置機構去，這個不對，所以才希望社會局跟勞工局一起來協力去做改變，重新把職務做調整，即便他只能做機械式的事情，但也還是可以再做的。

社會局盧局長禹璁：

是。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我看到你們回覆的方式覺得還蠻遺憾的，回覆說社會局於需求評估生涯轉接職務的時候，會評估他，如果評估起來這個身心障礙者具有就業意願或職業訓練等需求，就轉介勞工局，我請教一下你的評估能量在什麼地方？在你們的回函上面是看不到的，全部都是用抽象描述的方式。你們又講，身心障礙者無意就業或能力尚不足已進入職場，則依其能力需求連結社區式服務接受生活自理能力等訓練，我請教一下，我們目前有多少社區式服務能夠接住？就現實來講，單單你現在小作所裡面的人力能量都有限，說要跟勞工局媒合，你的轉介媒合機制是什麼？SOP 又是什麼？你說要建立身心障礙者職場支持網路，提供成功就業經驗來增強身心障礙者就業意願，降低他轉銜就業的困難。那我就覺得奇怪了，如果人家的成功經驗可以直接複製貼上到另外一個人，讓他也成功來講的話，你就不會在這邊當社會局長，我也不會在這邊當議員了，我們人人都是郭台銘，

人人都是巴菲特！哪那麼容易哪麼簡單！再來，還要配合勞工局的職務再設計跟分享身心障礙者成功經驗，你們到底在想什麼？有沒有心要面對這個問題啊？

身心障礙福利科洪科長筱涵：

跟議座說明一下，上次議座關心這個議題之後，我們內部有跟勞工局這邊討論過，我們自己有發現就像您說的，其實障礙者他有一些他的優勢，也蠻適合透過職務再設計進入職場，但對於企業主來說，他們可能沒有發現這個部分要怎麼運用。所以我們目前的作法是已經有和經發局的商業科這邊聯繫，剛好最近經發局的商業科會有兩場商標設計的說明會，會有很多的企業來，他們會在這個會議當中提供 30 分鐘給社會局還有勞工局，我們會去介紹一下障礙者的特質跟職務再設計的部分，希望可以鼓勵釋出適合身障者的工作，其實他現有的工作透過職務再設計再做一些調整就可以做了。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

對，要先知道什麼是職務再設計，而不是甩手只要有一個招商機會，大家就出來狂秀一波，我根本到現在都沒有看到你們所謂職務再設計的那一套做法，你們只是反覆的把職務再設計這個東西套到日常的活動宣傳裡面，說會做職務再設計，可是你沒有告訴我什麼是職務再設計！

身心障礙福利科洪科長筱涵：

有，我們科自己有兩個身障的同事，後續有做。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你公文回了嗎？局長，這件事不能怪科長，你跟勞工局要先幹這件事情，你要先把主軸、架構先弄出來，不然我們怎麼做？

社會局盧局長禹璁：

是。

主席：（李議員偉智）

接下來請陳皇宇議員。

陳議員皇宇：

感謝主席。今天是社會局跟衛生局兩個局室，本席這裡有得到一些訊息很想問，我得到的訊息是衛生局的業務即將跟社會局照管中心的業務合在一起，這樣的業務和配起來之後變成衛生局 2.0，社會局局長，有這樣的訊息嗎？

社會局盧局長禹璁：

我們現在正在談合併的事情，我們這邊切割，他們那邊合併。

陳議員皇宇：

這件事情的進度如何？

衛生局李局長翠鳳：

上一個會期大家有提出來，整個台灣地區現在只有我們的長照還在社會局，所以希望移回來，市長有交辦我們兩個局處趕快協調，我們已經完成業務的盤點還有人力，將來移到我們這裡之後，剛好長照進入到 2.0 甚至 3.0 的階段，所以我們衛生局這裡就會參照目前其他六都在辦理業務的人力，比如一個科大概要有多少股等，我們目前已經有簽辦一個想法，公文正在市府的流程。

陳議員皇宇：

我一直想要問一下，你切過去之後，你會加強長照 2.0 的業務，還是跟以前一模一

樣沒有改變？

衛生局李局長翠鳳：

因為現在政策有很多的要求，我們當然希望可以跟上，不要在後面追，所以我們在未來的規劃上會希望可以一次到位。

陳議員皇宇：

因為社會局的照管中心業務很繁重，而且你也已經很純熟在做這件事情了，相對的，要把這樣的業務撥過去給衛生局的時候，衛生局做好準備了沒就變得很重要，才不會拉過去之後整個變成一團亂，甚至也差不多是這樣而已，那這樣的意義在哪裡？是因為全國只有我們臺南市還沒有把照管中心的業務拉過去衛生局而做的話，這樣子有意義嗎？很大一個問號。

社會局盧局長禹璁：

第一個，接下來長照 3.0 的醫學成分比較高，第二個，我們是人、事、地全部都移給衛生局，所以它運作本來就很順利了，接下來再把長照 3.0 加進去就可以了。

陳議員皇宇：

所以包含未來的遠端醫療、AI 的判讀，甚至物理治療或復健治療師他們要在一個場所做治療，您的感覺起來就會變得更豐富的感覺，就跟你去澎湖考察看了一下之後發現人家做的不錯。

社會局盧局長禹璁：

是。

陳議員皇宇：

那時間點呢？一直沒有討論時間點?什麼時候？deadline 是什麼時候?

衛生局李局長翠鳳：

衛生局還在跟社會局協調的部分，要牽涉到很多組織、變更等等，我們自己不知道到底時間上可不可以來得及，我們 115 年比較有可能可以把業務接過來。

陳議員皇宇：

115 年？

衛生局李局長翠鳳：

對，因為 114 年的預算編列都已經在社會局，我們希望比較正常的銜接，假如可以順利的移過來，看是不是明年編 115 年預算的時候就開始編到衛生局，到時候業務可以順利的來移撥。

陳議員皇宇：

所以在 115 年中，還是 115 年底？

衛生局李局長翠鳳：

我們目前的想法是希望能盡早就盡早。

陳議員皇宇：

所以這還是一個很模糊的地方，既然它偏重醫療的部分，我想局長這裡就要有一些創新的想法出來了，不然怎麼跟得上、超越現在照管中心以及現有社會局的框架？比如我們去看了一下別人，發現物理治療跟職能治療其實放在社區上是有它的好處，甚至我剛剛有提到，我們大部分都是家醫科的醫生去居家服務，但是如果真的要有一些資格的評估，是不是在區域醫院以上的醫生也可以跟你配合來到居家，不用舟車勞頓把他載出

來，也不需要富康巴士這麼辛苦，我想這個都是未來的助力，這個啟承的部分我想要給所有的議會同仁知道，你們即將要有這樣的業務轉折了，謝謝。

主席：（李議員偉智）

接下來請沈震東議員。

沈議員震東：

謝謝主席。社會局局長，今天早上有跟你提到今年的長者福利的服務有在推動跟推陳出新，當然大家會去做比較，就像市長所說的，有別的地方傳出這樣的消息而去做比較，我想這個部分也是值得社會局去思考的，在未來福利服務的政策上是不是可以往這個方向去邁進？

社會局盧局長禹璁：

我們是朝這個方向來做設計，如果是補1,200元的話，經費應該是2億多。

沈議員震東：

好，謝謝局長。接下來的問題向跟你請教，我想現在社會局真的是非常辛苦，不管事6樓或是隔壁的社福大樓，都可以看到晚上都非常的亮，大家加班的很辛苦。有民眾或基層的公務人員就有反映夜間托育非常難找，局長有聽過這樣的話嗎？

社會局盧局長禹璁：

我們也有夜間托育，但只有1個點而已。

沈議員震東：

沒錯，全臺南只有東區的那一點，在這樣的狀況之下，除了112年勞工統計夜間工作站8%的照顧需求之外，我們更多公務人員也應該有這樣的需求，局長你認不認同？

社會局盧局長禹璁：

對，有這個需求。

沈議員震東：

那有沒有想要往這個方向去邁進、努力，去媒合推動一下這樣的需求情況？

社會局盧局長禹璁：

如果需求比較多的話，我想應該再來做擴大。

沈議員震東：

應該不是說擴大而已，還要加長時間。

婦女及兒童少年福利科許科長乃文：

跟議座說明，其實剛剛講到善化的夜間是屬於臨托，但如果是屬於常態性的，它還是要回到一般正常的托育服務，以居托人員來講，它還是可以提供夜間的托育服務。

沈議員震東：

沒錯，可是現在就是很少，我直接說好了，側面瞭解之後發現公務人員其實是有需求的，但確實在臺南市，甚至是我們市政府附近的服務確實沒有這樣的服務需求，在這樣的狀況之下，看到問題了，希望可以有被解決的可能性。

社會局盧局長禹璁：

是，我們會根據需求來看看要如何做設計。

沈議員震東：

好，謝謝局長，局長請坐。衛生局局長，大腸直腸癌的篩檢目前臺南市是在50歲到75歲有每2年免費一次，對不對？

衛生局李局長翠鳳：

對。

沈議員震東：

我想，現在大家都外食，我們的國民健康科有在推動食品安全的重要性，或者要怎麼吃才健康，但文明病的年齡確實越來越下探，未來是不是有機會幫年輕族群來爭取這樣的檢測？

主席：（李議員偉智）

會後再答覆沈議員，接下來請朱正軒議員。

朱議員正軒：

謝謝主席。局長，我們再延續剛剛的議題，我知道這個有經費的考量，我沒有要求一步到位，但是至少要開始思考這個問題，因為長輩確實在交通移動上會有一些困擾，我們有沒有曾經提幾個方案給市長，讓市長做決定過？還是永遠只有 YES OR NO 的討論？

社會局盧局長禹璁：

我們其實六都之外，也考慮到很多方案，因為現在最低的是高雄市，比如我們是 600 元、1,000 元、1,200 元等我們現在都有研提，有適當的時間再來跟市長做討論。

朱議員正軒：

因為這個東西是點數制的，也就是說你沒有用完並不會就真的支付了，其實是有需要的人就來使用，我還是希望社會局可以多提幾個方案給市長讓市長做決定，至少往這個方向前進，因為我們真的接到很多人的陳情，說他們連想搭交通都沒辦法，雖然我們公共運輸在努力中，不過跟有軌道運輸的其他五都比起來還是落差很大。

社會局盧局長禹璁：

不過我們坐公車是免費。

朱議員正軒：

當然可以搭公車最好，但是他們會向我們反映這個問題表示他們搭公車不夠方便，所以才會延伸出現在這個問題。

社會局盧局長禹璁：

是，謝謝議座的建議。

朱議員正軒：

點數是一個很好的方法，我們並不是真的實際支出這麼多，而是編了以後真的有需要的人用到了之後，我們再來支出這些東西，要讓市長很清楚知道這件事情，局長，這部分可以承諾確實會提幾個方案給市長嗎？

社會局盧局長禹璁：

對，我們會提幾個方案給市長做決定。

朱議員正軒：

好，謝謝局長。這個就是我們剛剛在講的，其實我們現在一直在強調市民卡，臺南市這麼多人住進來，結果戶籍人口都沒有增加，因為他雖然生活在臺南市，但是很多人的戶籍還是維持在原縣市，近幾年臺南產生一直有新的人住進來，但是我們的戶籍人口一直沒有成長的現象，所以市民卡就是一個很好的平台，因為要享受市民的福利，戶籍一定要在這邊，當我們把我們的福利提升的時候，會越來越多人會願意搬進來。像我好

幾個朋友，可能是高雄人嫁給臺南人，結果生小孩之後戶籍仍然在高雄，這就是很現實的問題，我們總人口成長沒有改變，不過是縣市之間在搶人，可是我們臺南市軍備競賽裡面我們是處於弱勢的，所以長輩的部分拜託社會局再繼續努力。

社會局盧局長禹璁：

會來努力。

朱議員正軒：

關於長照，一里一據點這個問題也是要討論一下，其實設照一里一據點是C級的，但是在高雄，他醫事的C的據點是比較多的，這個部分我要拜託衛生局跟社會局一起來瞭解，我們以一里一據點來看的話，其實我們現在巷弄C站跟里的比例是偏低的，而且還不是低一點，是低很多，我想我們既然長照服務要普及，據點拜託社會局這邊要來加強。像高雄醫事C的單位這麼多的話，代表他很多是跟醫療機構合作的，鼓勵醫療機構來成立社區關懷據點，所以這個部分也拜託衛生局這邊研究一下高雄的作法，為什麼他們有辦法讓這麼多專業的醫療機構來設置這樣的醫事據點。

衛生局李局長翠鳳：

剛剛講到，其他縣市的據點可能都已經是衛生局在主管，所以他們有一些醫療的部分比較容易結合，剛剛也提到3.0將來就是在醫療上面，我們兩邊就是合作。

朱議員正軒：

所以拜託兩位局長，我們來思考一個問題，以一里一據點來看，我們現在的比例確實在六都裡面排得特別低的，所以這個是我們可以提升的方向。主政的局處應該是在社會局，這個地方再拜託局長幫我們關心一下，列為一個檢討的指標。再來是社工師人力的問題，這個看起來是全市的問題，因為一直有人在抱怨說找不到社工，可是如果看新北市的缺額率是遠高過我們的，也就是說這個是全國性的問題，這樣的話，我們地方政府有責任持續把這樣的情況告訴中央，不管是提升社工師待遇或是其他情況，我們要想辦法把缺額的部分補齊。

社會局盧局長禹璁：

有，我們在開會時都會跟中央反映。

朱議員正軒：

這樣請科長這邊補充一下社工師的部分。

社會工作及家庭福利科郭科長元媛：

跟議座報告，社工師的部分我們除了跟大專院校做合作以外，我們也是配合了社工助理的部分，讓還沒進入到職場的3年級升4年級學生先來社會局做實習。

朱議員正軒：

所以再回來一個問題，就是我們的久任獎金，這個不管是托育的保母或是社工這個部分，也許這都是要努力的方向

主席：（李議員偉智）

向各位議員報告，在鄭佳欣議員發言之後休息10分鐘，鄭佳欣議員請。

鄭議員佳欣：

謝謝主席。請教衛生局局長，我看你們的工作報告後想瞭解一下第5項有一個「補助嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗」，這方面你們說已經在113年5月31日起擴大補助原住民重大傷病及罕見疾病之新生兒，只要有符合這些資格都可以到各衛生所去做免費的接種

。我想瞭解一下，你們有沒有針對這些邊緣戶的新生兒也可以提供這樣免費的接種？我那天才剛在跟盧局長討論，現在很多家庭其實很可憐，礙於他低收或中低收都沒辦法申請過，邊緣戶實在很多，光是我的服務處幾乎每個禮拜都一定會接到，可能有些都會介紹到愛心會，現在我想要瞭解針對這些邊緣戶，你們手邊有沒有這樣的檢討？

衛生局李局長翠鳳：

目前我們沒有所謂邊緣戶的資料，我們有的資料都是從社會局這邊來，有中低收、低收，或者我們前面剛剛提到的這些對象，都是我們可以從健保或從哪裡來，所以我有分母。

鄭議員佳欣：

未來針對這些邊緣戶，社會局也認定他確實很可憐、很需要這樣的協助的。

衛生局李局長翠鳳：

假如有一些是被認可的，例如說社會局有名單可以提供的話，我想我們也來儘量來協助。

鄭議員佳欣：

好，謝謝局長。另外關於第 6 點「本市各區心理衛生中心增加夜間及假日時段」，目前你們這邊是由假日自殺關懷防治輪流值班，我想瞭解一下，一般假日會有幾位訪視員值班？

心理健康科陳科長月英：

跟議座報告，值班我們會依照個案的需求，不見得有固定的人員值班，但至少會有一位值班。

鄭議員佳欣：

一位這樣子是夠的嗎？周末的時段都是幾點到幾點？因為你們有寫到你們現在假日也會有訪視員輪流值班，因為民眾平常時都要上班，假日可能有這樣的需求，我想瞭解所謂的值班一般會有幾位人員在那邊值班受理高風險的案件？

心理健康科陳科長月英：

我們每個訪員都有個別的服務個案，他會依照個案的需求跟他協調是要夜間訪視還是假日，他會配合個案的時間去訪視，所以是依照個案的需求來調整他們的上班時間。

鄭議員佳欣：

那這樣你們這邊怎麼會寫到自殺關懷防治員輪流值班？

心理健康科陳科長月英：

沒有，那個是臨時有狀況的現場，會再通知其他人來協助。

鄭議員佳欣：

好。這個業務性質是屬於比較高風險的，我們衛生局這邊是不是也有顧慮到訪視員的安全？畢竟這個業務性質是屬於比較高風險的，最基礎的自我防禦或是身上會不會配戴一些防衛措施等，我覺得蠻重要的，也要顧慮到他們的安全。

心理健康科陳科長月英：

有，有買一些工具給他們做基本的防護措施，另外緊急狀況，他們可以臨時通知警察配合他們去訪視。

鄭議員佳欣：

所以最基本的配備他們都有，包括這些基礎的訓練，這些訪視員都會？

心理健康科陳科長月英：

另外我們也有一些舒壓課程，因為他們所訪視的個案對他們來說也壓力很大。

鄭議員佳欣：

對，沒錯，這個也是蠻重要的。因為本身要去幫忙協助這精神上比較…

心理健康科陳科長月英：

他們一定要自我調適。

鄭議員佳欣：

好，謝謝科長。

主席：（李議員偉智）

休息 10 分鐘。

主席：（陳議員皇宇）

繼續開會，我們請李宗翰議員。

李議員宗翰：

謝謝主席。我想先請教社會局長，在我們經濟部訂定的方案裡面，他如果要領到淹水 50 公分的補助，要以臥室、客廳、飯廳、廁所、浴室為限，像這樣子他們每戶可以領到 2 萬元，但是後面有個但書，就是經直轄市認定之屋內居住空間得視為住屋範圍，想請問一下，什麼叫做生活相關聯之屋內居住空間？局長你們如何認定?

社會局盧局長禹璁：

我們通常都是由現場去現勘的人員認定，認定的原則也是臥室、客廳、飯廳等等，如果有這些設備，也在那邊確實使用，就會被認定為住屋。

李議員宗翰：

換句話說，你覺得第四行之後經直轄市認定…住屋範圍是多寫的？

社會局盧局長禹璁：

沒有，如果我們再去複勘的話，可以再看一次。

李議員宗翰：

看起來你們也沒有在額外認定哪些空間是生活空間，是不是這樣？就是他第一、二行寫了什麼，你們就照他第一、二行這樣去認定而已。

社會局盧局長禹璁：

社會局這邊是還沒有碰到第二段。

李議員宗翰：

所以你覺得是民政局的問題，是民政局沒有去認定？

社會局盧局長禹璁：

不是，是區公所的第一線人員。

李議員宗翰：

對，是民政局沒錯。所以你認為這個責任是在民政局身上，他們沒有協助民眾去做認定。

社會局盧局長禹璁：

沒有，他們有協助。

李議員宗翰：

有協助民眾去做認定？你確定？

社會局盧局長禹璁：

我們解釋從寬。

李議員宗翰：

所以除了車庫以外，全部都不行？

社會局盧局長禹璁：

車庫要看是什麼形式的車庫，有一種是在外面的，有一種是在房子裡面的。

李議員宗翰：

那我想請假一下，目前鹽水大眾的狀況是，車庫主要是依照地方政府前述的原則認定，至於地下室淹水的問題，如果地下室沒有臥室、客廳、飯廳、廚房等，也未達50公分的話，也是由地方政府認定，我想請教一下，地下室有沒有你們補助的內容？

社會救助科楊科長瑞美：

跟議座說明，以臺南市的狀況來講，就是經濟部訂定的認定標準，我們就是以住屋，有臥室、客廳、飯廳、廚房、浴室等其中一個空間有淹水達50公分以上，我們就符合補助的標準。

李議員宗翰：

我想要跟局處分享，照片這些地方不論淹20公分、淹50公分，基本上都會造就了財產損失，所以不論是淹在車庫、房間或淹在哪個地方，他可能真的運氣不好，他們家廁所、廚房蓋在比較裡面的地方，客廳可能沒有放在一樓，或是家裏習慣沒有放客廳，導致於我們公所到現場說未達50公分，但他前面淹的亂七八糟，可是可以認定的地方都不到那個高度，請問社會局怎麼看待這件事情？

社會救助科楊科長瑞美：

跟議座說明一下，我們剛剛講的住屋的空間是指剛剛講的那些空間其中一個空間有淹水達50公分以上就可以符合補助，除非是他的房屋結構設計一樓只是車庫然後沒有其他生活居住空間的情況。

李議員宗翰：

所以你覺得一樓只是車庫就不會放置其他內容？你覺得他們家只淹車庫跟只淹客廳的差別不會有太大的落差？

社會救助科楊科長瑞美：

這部分跟議座說明，以各縣市還有其他都目前淹水救助的標準，都是以這樣的居住空間來做認定。

李議員宗翰：

所以把車庫排除掉了，那接下來家裡任何一個空間如果是跟生活相連的，可能通道有達到50公分，那請問是要量通道還是要量客廳還是要量廚房？局長，這件事情你知道嗎？不知道？

主席：（陳議員皇宇）

我們請陳碧玉議員。

陳議員碧玉：

謝謝主席。社會局盧局長，我們新市區的社會文化教育館的幼兒園已經遷到新的園所去了，現在這個地方整體來說是做怎樣的規劃？目前的進度到哪裡了？

婦女及兒童少年福利科許科長乃文：